



Enfermedades Parasitarias de la Piel

Guía de Estudio Detallada: Escabiosis y Pediculosis

Ectoparasitosis

(Enfermedades infectocontagiosas ligadas a pobreza, hacinamiento y migración)

Escabiosis

(Sarna, Acarosis)

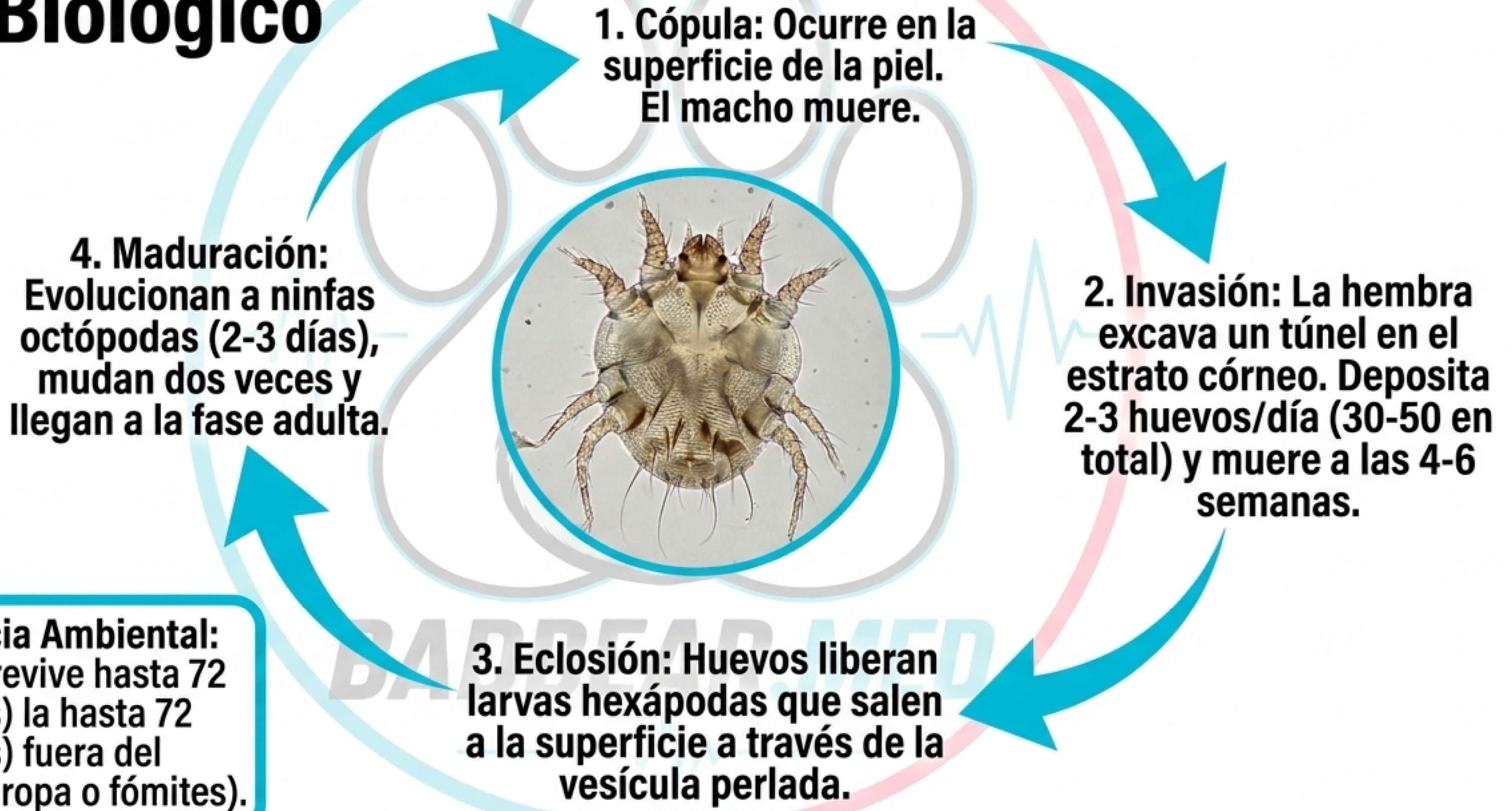
- Agente: *Sarcoptes scabiei* var. *hominis*
- Dieta: Queratina (Keratin)

Pediculosis

(Piojos, Ladillas)

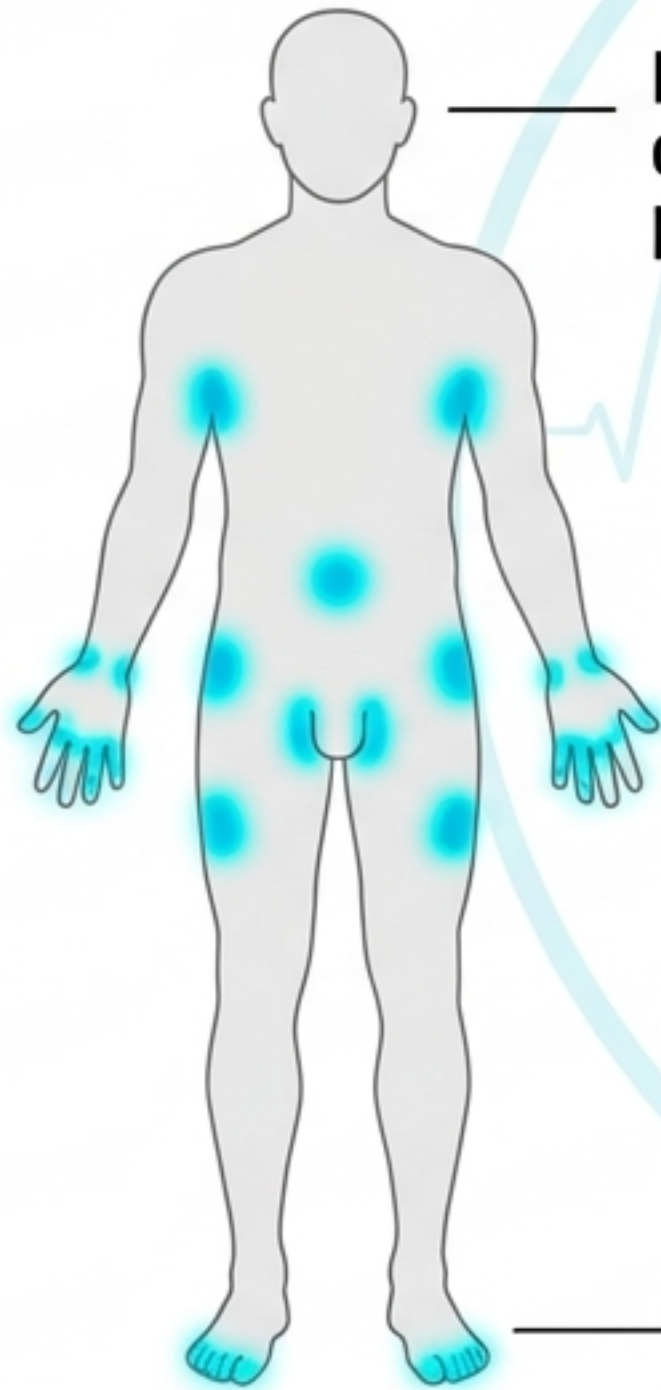
- Agentes: *Pediculus capitis*, *P. corporis*, *Pthirus pubis*
- Dieta: Sangre (Hematófagos)

Escabiosis: Etiología y Ciclo Biológico



Escabiosis: Topografía Clínica

Adultos



Respeto estrictamente
cara, cuero cabelludo,
palmas y plantas.

Lactantes / Neonatos



No respeta nada. Afecta
masivamente todo el
cuerpo, incluyendo cara,
palmas y plantas.



Semiología de la Escabiosis

Síntoma Principal: Prurito Nocturno Nocturno

Reacción de hipersensibilidad que se intensifica críticamente en la noche por la actividad del ácaro.



Signo Directo: Surco Acarino y Vesícula Perlada

El túnel en el estrato córneo y la vesícula brillante que sirve como orificio de salida.



Signos Indirectos: Pápulas Eritematosas

Reacción alérgica indirecta diseminada simétricamente en pliegues.



Nódulos Acarinos

Lesiones duras y profundas, predominantes en genitales masculinos (escroto/pene) y axilas.



Variante Severa: Sarna Noruega

- **Contexto:** Pacientes inmunosuprimidos (VIH, Lepra, desnutrición severa).
- **Clínica:** Placas hiperqueratósicas amarillentas generalizadas y fisuradas.
- **El Dato Clave:** Ausencia de prurito (debido a la falla inmunológica del huésped).
- **Carga Parasitaria:** Superinfestación masiva (miles de ácaros); extremadamente contagiosa.



Diagnóstico Laboratorial: Acarotest

1. Identificar la Vesícula perlada de Bazin.

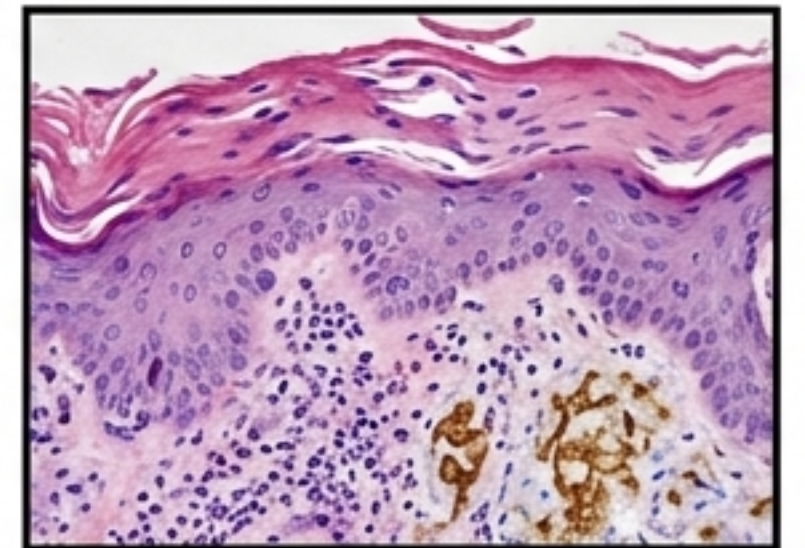
2. Raspado superficial con hoja de bisturí.

3. Colocar en lámina portaobjetos + Hidróxido de Potasio (KOH) al 10%.

4. Visualización microscópica del ácaro, huevos o heces.

Histopatología

Se observa Paraqueratosis (presencia anormal de núcleos celulares en el estrato córneo) e infiltrado inflamatorio con depósito de C3.



Matriz Farmacológica: Escabiosis

Fármaco	Concentración	Indicación / Método	Precaución Crítica
Permetrina	5%	Tratamiento de elección. Aplicar en todo el cuerpo.	Seguro en niños y gestantes.
Benzoato de Bencilo	10% (niños), 20% (adultos)	Régimen 5-5-5: 5 días uso, 5 descanso, 5 uso. (No mata huevos).	Riesgo de dermatitis por contacto severa.
Ivermectina	Gotas / Oral	1 gota/kg en ayunas. Repetir a los 4 o 7 días.	Uso sistémico.
Lindano	1%	Uso solo en adultos sanos.	NEUROTÓXICO. Contraindicado en niños y gestantes.
Vaselina Azufrada	5%	Alternativa barata para grandes brotes comunitarios.	Coloración amarillenta indeseable.

Introducción a la Pediculosis (Piojos)

Parásitos Hematófagos (Buscan sangre, no queratina).

Pediculus humanus capitis (Piojo de la cabeza)

Afecta el cuero cabelludo, especialmente en niños escolares.



Pediculus humanus corporis (Piojo del cuerpo)

El más grande (2-4mm). Vive y se esconde en las costuras de la ropa, pica el tronco.



Pthirus pubis (Ladilla / Pubis)

Transmisión sexual predominante. Apariencia más corta, ancha y similar a un cangrejo.



Pediculosis Capitis

- **Topografía:** Región retroauricular y occipital.
- **Signo Físico Principal:** Liendres (huevos) cementadas firmemente al tallo piloso mediante una proteína cementoide.
- **Complicaciones:** Prurito intenso -> Rascado profundo -> Impetiginización (infección bacteriana secundaria por estafilococo/estreptococo).
- **Respuesta Clínica:** Aparición de adenopatía occipital reactiva al impétigo (siempre palpar ganglios occipitales).



Pediculosis Corporis

Fase Aguda

- **Hábitat:** Se alojan en las costuras y pliegues de la ropa. Solo bajan a la piel para succionar sangre.
- **Clínica:** Lesiones eritematosas puntiformes (orificios de succión) y pápulas urticariformes en el tronco.



Fase Crónica y Complicaciones

- **Complicación:** Enfermedad de los Vagabundos (Melanodermia pediculósica).
- **Signo:** Máculas bronceadas extensas, hiperpigmentación y liquenificación debido al rascado crónico severo.



Pediculosis Pubis (Ladillas)

Transmisión:

Estrictamente **contacto sexual íntimo** o por compartir sábanas/fómites infectados.

Regla de Oro: Siempre descartar la presencia de otras **ETS** (VIH, Sífilis) mediante panel serológico completo.



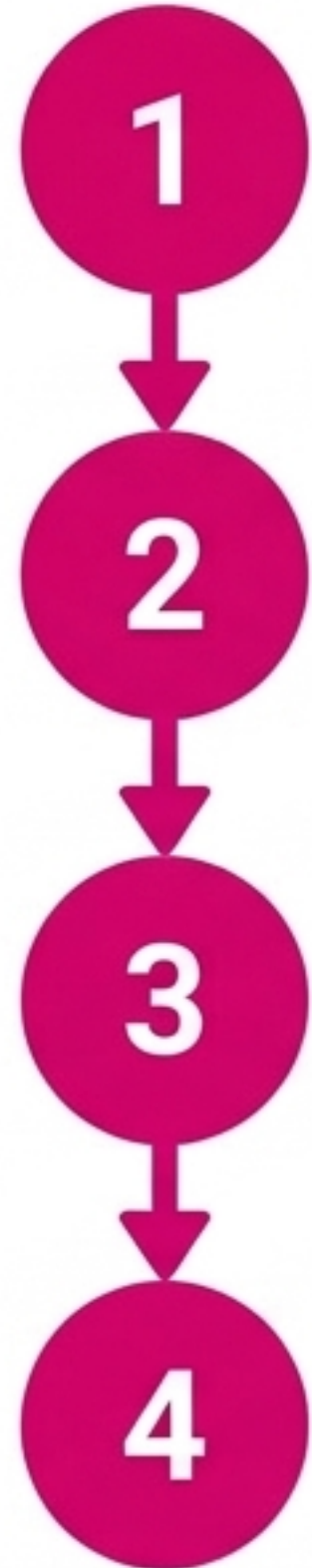
Signos Clásicos: Manchas de **polvo de café** en la ropa interior (micro-costras hemorrágicas) y **Máculas Cerúleas** (manchas azul-grisáceas en abdomen inferior por hematomas de succión).

Migración: En infestaciones severas, el parásito puede **tregar por el vello corporal** hasta axilas e incluso pestañas (requiere Fisostigmina 0.025%).

Matriz de Diagnóstico Diferencial

Entidad Clínica	Principal Diagnóstico Diferencial	Clave Clínica para Distinguir
Pediculosis Capitis	Dermatitis Seborreica	Las liendres no se desprenden fácilmente al tirar (están cementadas); las escamas seborreicas sí se desprenden y deslizan.
Pediculosis Corporis	Escabiosis / Dermatitis Herpetiforme	Presencia del ácaro en las costuras de la ropa (no en la piel permanentemente); la afectación respeta las áreas interdigitales típicas de la escabiosis.
Pediculosis Pubis	Eccema Genital	Evidencia de máculas cerúleas en piel y manchas de sangre (polvo de café) en la ropa interior.

Protocolo de Tratamiento (Pediculosis)



1. Aplicación Química: Aplicar champú pediculicida (Permetrina 1-1.5%, Lindano 1%, o Malatión) sobre el cabello húmedo.

2. Oclusión: Envolver la cabeza en un turbante (gorro de baño) dejándolo actuar por 10 minutos a 2 horas. Lavar posteriormente.

3. Disolución del Cemento (Paso Crítico): Aplicar solución de Vinagre al 50% con agua para disolver la proteína cementoide que fija la liendre al pelo.

4. Extracción y Repetición: Peinar meticulosamente el cabello húmedo con un peine fino (patrullero) de metal. Repetir todo el ciclo farmacológico a los 7 días para asegurar letalidad total.

Control Epidemiológico y Medidas Preventivas



Saneamiento Térmico

Lavado obligatorio de toda la ropa de cama y de vestir personal en ciclos de agua caliente, finalizando con secado directo al sol.



Manejo de Contactos

Tratamiento simultáneo y obligatorio para la pareja sexual (en P. pubis) y tratamiento profiláctico para todo el núcleo familiar conviviente.



Aislamiento Escolar

Exclusión temporal de los niños infestados del ámbito escolar, permitiendo su retorno solo tras completar la primera fase del tratamiento correcto.



Vigilancia Institucional

Control periódico y constante en escuelas, refugios e instalaciones sanitarias básicas para evitar reinfestaciones comunitarias masivas.